

약제 요양 급여의 적정성 평가 결과

이 베리스아마라 50%에 탄올틴크(1:1.5-2.5) 15mL/100ml 외 9개 성분 (이 베로가스트액, 한화제약(주))

☐ 제형, 성분·함량 :

- 이 약 100mL 중
 - 이 베리스아마라 50%에 탄올틴크(1:1.5-2.5) 15mL
 - 안젤리카뿌리30%에 탄올틴크(1:2.5-3.5) 10mL
 - 마트리카리아꽃30%에 탄올틴크(1:2-4) 10mL
 - 캐러웨이열매 30% 에탄올틴크(1:2.5-3.5) 10mL
 - 밀크시슬열매 30% 에탄올틴크(1:2.5-3.5) 10mL
 - 밤엽 30%에탄올틴크(1:2.5-3.5) 10mL
 - 페퍼민트엽 30%에탄올틴크(1:2.5-3.5) 5mL
 - 백굴채30%에탄올틴크(1:2.5-3.5) 10mL
 - 감초30%에탄올틴크(1:2.5-3.5) 10mL

☐ 효능 효과 :

- 기능성 소화불량 및 과민성 대장증후군과 같은 기능성, 운동성 위장질환치료
- 위염증상치료의 보조요법 (복통, 가슴쓰림, 팽만감, 위경련, 구역질)

☐ 약제급여평가위원회 심의 일

2011년 제14차 약제급여평가위원회 : 2011년 11월 17일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 비급여

- 신청품은 “기능성 소화불량 및 과민성 대장증후군과 같은 기능성, 운동성 위장질환치료와 위염증상치료의 보조요법(복통, 가슴쓰림, 팽만감, 위경련, 구역질)”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 임상적 유용성을 입증하는 근거가 부족하고, 소요비용이 대체 약제보다 고가로 비용 효과적이지 않으므로 급여의 적정성이 없음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “기능성 소화불량 및 과민성 대장증후군과 같은 기능성, 운동성 위장질환치료와 위염증상치료의 보조요법 (복통, 가슴쓰림, 팽만감, 위경련, 구역질)”에 허가받은 약제로, 대상 질환은 희귀질환에 해당하지 않으며, 현재 동일 적응증에 허가받은 itopride, metoclopramide 등이 등재되어 있으므로, 대체가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 9개의 생약성분으로 구성된 복합제로써, 약리 기전은 명확히 밝혀지지 않았으나¹⁾, 소화기관 근육의 운동성을 변화시키는 작용을 하는 것으로 생각됨²⁾. banana, capsaicin, acupuncture 등과 유사하게 기능성 소화불량 및 과민성 대장 증후군 치료에 대체(Alternative, palliative)의약품으로 소개되어 있음³⁾.
- 기능성 소화불량 환자(n=124)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, cisapride 대조 3상 임상시험을 4주간 수행한 결과⁴⁾, 신청품 투여군(STW5)이 GIS⁵⁾ score 개선 효과(12.1; 95% CI 6.6~17.6)가 cisapride투여군(10.9; 95% CI 5.1 ~16.7)에 비열등함을 보임(p<0.0001).
- 기능성 소화불량 환자(n=77)를 대상으로 무작위배정, 단일 맹검, Metoclopramide 대조 3상 임상시험⁶⁾을 2주간 수행한 결과, 통증, 오심, 트림, 가슴쓰림, 위경련, 구토감, 포만감, 식욕부진 등의 증상이 개선된 시점이 신청품 투여군과 Metoclopramide 투여군 간 유의한 차이를 보이지 않음.
- 기능성 소화불량 환자(n=60)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상시험⁷⁾을 4주간 수행한 결과, 위약 대비 GIS score 개선 정도가 신청품(STW5) 투여군(8.1; 95% CI 4.4~11.8)이 위약 투여군(1.5; 95% CI -1.1~4.1)에 비해 유의하게 개선되었음(p<0.001).

- 기능성 소화불량증 환자 425명을 대상으로 GIS score의 변화를 4주간 분석한 RCT 3편의 결과에 대한 메타 분석⁸⁾ 결과, Iberogast 액 투여군에서 위약 투여군 대비 GIS score의 유의한 감소가 나타남.(RR 0.22; 95% CI 0.11~0.47; p<0.001).
- 과민성 대장 증후군 환자(n=103)를 대상으로 무작위배정, 이중 맹검, 위약 대조 3상 임상시험⁹⁾을 4주간 수행한 결과, Irritable bowel syndrome(IBS) symptom sum score에서 신청품(STW 5)투여군이 위약 투여군에 비해 유의하게 개선되었음(p=0.001). 복부 통증의 mean sum score도 신청품(STW 5) 투여군이 위약 투여 군에 비해 유의하게 개선되었음(P=0.0009).
- 대체약제와 비교한 임상적 근거가 부족한 점, 현재 임상에서 동 약제를 대신하여 사용할 수 있는 대체약제가 많은 점 등을 고려할 때 진료상 필수 약제가 아님.¹⁰⁾

○ 비용 효과성

- 신청품은 “기능성 소화불량 및 과민성 대장증후군과 같은 기능성, 운동성 위장질환치료와 위염증상치료의 보조요법 (복통, 가슴쓰림, 팽만감, 위경련, 구역질)”에 허가받은 경구제이며, 허가사항, 임상진료지침¹¹⁾¹²⁾, 학회의견¹³⁾¹⁴⁾¹⁵⁾에 따라 prokinetics (itopride, mosapride citrate, levosulpiride, domperidone maleate, metoclopramide HCl), 진경제(mebeverine HCl, pinaverium bromide, trimebutine maleate, fenoverine, octylonium bromide, tiquizium bromide), enzyme preparation(bromelain 50mg 외 9개 성분, bromelain 50mg 외 4개 성분)을 모두 대체약제로 고려함¹⁶⁾.
- 신청품은 임상 시험 결과 기타 prokinetics, 진경제 대비 임상적 유용성이 개선되었다고 보기 어려우며, 신청품의 1일 소요비용은 ■■■¹⁷⁾으로, 대체약제 가중일일투약비용인 ■■■ 대비 고가로 비용 효과적이지 않음¹⁸⁾.

○ 재정 영향

- 해당적응증의 대상 환자수¹⁹⁾는 ■■■이고, 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾은 1차년도에 약 ■■■, 3차년도에 약 ■■■이 되고, 대체약제의 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■, 3차년도에 ■■■원이 증가될 것으로 예상됨²²⁾.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 독일, 스위스에 등재되어 있음.

Reference

- 1) Gastroenterology Clinics - Volume 40, Issue 1; Complementary and Alternative Medicine for the Irritable Bowel Syndrome (March 2011)
- 2) J. MELZER et al., Meta-analysis: phytotherapy of functional dyspepsia with the herbal drug preparation STW 5 (Iberogast) ; Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 1279-1287.
- 3) Feldman: Sleisenger and Fordtran's Gastrointestinal and Liver Disease, 9th ed. CHAPTER 127. Complementary and Alternative Medicine
- 4) W. Rosch et al., A Randomised Clinical Trial Comparing the Efficacy of a Herbal preparation STW 5 with the Prokinetic Drug Cisapride in Patients with Dysmotility Type of Functional Dyspepsia. ; Z. Gastroenterol 2002; 40; 401-408.
- 5) Gastrointestinal symptom score
- 6) Dr. med. K. Nicolay et al., Functional Gastroenteropathies in the Therapeutic Blind Comparison of Metoclopramide with the Phytopharmaceutical Iberogast ; Gastro- Entero-Hepatologie2 (1984)4
- 7) A. Madisch et al., Commercially available herbal preparation and its modified dispense in patients with functional dyspepsia. Results of a double-blind, placebo-controlled, randomised multicentre trial.; Gastroenterol 2001; 39: 511-517.
- 8) J. MELZER et al., Meta-analysis: phytotherapy of functional dyspepsia with the herbal drug preparation STW 5 (Iberogast) ; Aliment Pharmacol Ther 2004; 20: 1279-1287.
- 9) A. MADISCH et al., Treatment of irritable bowel syndrome with herbal preparations: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled, multi-centre trial. ; Aliment Pharmacol Ther 2004; 19: 271-279.
- 10) 중앙심사평가조정위원회 2011.11.10.
- 11) Gastroenterology Clinics - Volume 40, Issue 1; Complementary and Alternative Medicine for the Irritable Bowel Syndrome (March 2011)
- 12) British Society of Gastroenterology : Guidelines on the irritable bowel syndrome: mechanisms and practical management - 2007
- 13) 대한내과학회()
- 14) 대한소화기학회()
- 15) 대한장연구학회()
- 16) 동일 성분의 정제 또는 캡슐제가 있는 내용액제(시럽 및 현탁액 등)는 요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항(보건복지부 고시 제 2011-74호)에 따라 요양급여 인정이 가능하나, 신청품은 동일성분의 정제 또는 캡슐제가 있는 내용액제에 해당하지 않고 신청품은 소아-성인 모두에게 사용될 수 있다는 점을 고려하여 정제 및 캡슐제, 액제를 모두 고려하여 대체약제를 검토하였음.
- 17) 1일 3회 투여를 기준으로 산출함(성인 투여 기준).
- 18) .
- 19) .
- 20) 제약사제출 예상 사용량()
- 21) 절대재정소요금액 = 제약사제출 예상사용량 x 신청약가
- 22) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재전후의 청구비중과 동일하다고 가정함.

$$\text{재정증감액} = \text{도입후 재정소요금액}^{\text{a)}} - \text{도입전 재정 소요금액}^{\text{b)}} \\
\text{a)} \sum (\text{도입 후 년도별 대체약제예상사용량} \times \text{대체약제 투약비용}) + (\text{년도별 신청품 점유율 적용 예상사용량} \times \text{신청약가}) \\
\text{b)} \sum (\text{도입전 년도별 대체약제 예상사용량} \times \text{대체약제 투약비용})$$